

360° KAPSAMLI KLİNİK YÖNETİCİ VE KARAR DESTEK RAPORU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÖZEL SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ VERİ ENTEGRASYONU

Rapor Tarihi: 10 Eylül 2026 | Değerlendirme Evresi: Ameliyat Sonrası 204. Gün (6.6 Ay)

Hasta Adı: Alaattin SÖNMEZ | T.C. Kimlik No: 00000000000 | Yaş/Cinsiyet: 64E (01.01.1962) | Kan Grubu: 0 Rh (+)Pozitif

1. YÖNETİCİ ÖZETİ VE KLİNİK İNDEKSLER

1.1. Biyometrik ve Klinik Künye

- Primer Tanılar:** Stanford Tip A Aort Diseksiyonu (DeBakey Tip I), 5.3 cm Asendan Aort Anevrizması, Ciddi Aort Kapak Yetmezliği (*Hagan et al., 2000 [17]; Erbel et al., 2014 [15]*).
- Cerrahi Operasyon:** Acil Bentall Prosedürü (20 Şubat 2026, Özel İskenderun Gelişim Hastanesi, Doç. Dr. Emre Kubat). 32 mm dokuma Dacron vasküler greft (Maquet Intergard Bovine), 25 mm çift yapraklı mekanik aort protezi (CORCYM Carbomedics Standard Aortic) ve koroner buton reimplantasyonu (*Bentall & De Bono, 1968 [19]; Lau et al., 2022 [21]*).
- Sekonder Cerrahi / Komplikasyon:** Sternal yara dehissensi ve derin enfeksiyon revizyonu (23–28 Temmuz 2026, debridman, rewiring çelik sütürasyon, kan transfüzyonu) (*El Oakley & Wright, 1996 [13]; Kaul, 2017 [31]*).
- Temel Klinik Göstergeler (08–10 Eylül 2026):**
 - Kan Basıncı (7 Günlük Ortalama): **111 / 75 mmHg** (Hedef $\leq 120/80$ mmHg ile uyumlu) (*Mancia et al., 2023 [1]*).
 - Koagülasyon (Son INR): **2.12** (10 Eylül 2026 Test #92; Mekanik aort kapağı hedef aralığı 2.0–3.0 içinde) (*Vahanian et al., 2022 [4]*).
 - Terapötik Aralıkta Kalma Süresi (Rosendaal TTR): **%54.6** (Labil antikoagülasyon göstergesi) (*Rosendaal et al., 1993 [6]*).
 - Hemoglobin / Hematokrit: **9.7 g/dL / %29.7** (Ağır mikrositer demir eksikliği anemisi) (*Goddard et al., 2021 [9]*).

- o Serum Ferritini / Serum Demiri: **19.0 µg/L / 15.0 µg/dL** (Tükenmiş demir depoları) (*Snook et al., 2021 [10]*).
 - o C-Reaktif Protein (CRP): **11.3 mg/L** (Referans: 0–5 mg/L; gerileme trendinde) (*Horan et al., 2008 [11]*).
 - o Böbrek / Karaciğer Fonksiyonları: Kreatinin 1.02 mg/dL, eGFR 75.58 mL/dk, ALT 14 U/L, AST 14 U/L (Tamamen korunmuş) (*Inker et al., 2021 [95]*).
-

2. PATOFİZYOLOJİK VE ÇOK DİSİPLİNLİ DEĞERLENDİRME

2.1. Hemodinamik Stres ve Kronik Rezidüel Tip B Diseksiyon Dinamiği

Hasta, ameliyat lojunda intakt 32 mm Dacron greft taşımakla birlikte; arkus aortadan başlayıp iliak bifurkasyona dek uzanan patent bir rezidüel Tip B diseksiyon flebine sahiptir (*Fleischmann et al., 2022 [14]*). Aort duvarındaki lümen içi pulsatif gerilim ve kesme gerilimi (dP/dt), sistolik kan basıncı ile doğrudan orantılıdır (*Evangelista et al., 2024 [3]*). Nisan 2026 ortasında evde yaşanan 168/103 mmHg seviyesindeki hipertansif sıçramalar, anevrizmatik yalancı lümen rüptürü açısından kritik risk teşkil etmiştir (*Melby et al., 2013 [22]*). Karvedilol (Dilatrend 6.25 mg 2x1) ile miyokard kontraktilesi baskılanırken, Ağustos ayında eklenen perindopril (Coversyl 5 mg 1x1) vasküler rezistansı kırarak Eylül ayı ortalamasını 111 mmHg seviyesine çekmiştir (*Tadros et al., 2019 [24]*).

2.2. Tromboembolizm, Kanama ve İlaç Etkileşim Kinetiği

Bileaflet mekanik aort kapağı taşıyan hastada ömür boyu Warfarin kullanımı esastır (*Otto et al., 2021 [5]*). Ancak Mart ayında yaşanan INR 8.46 atağı ve Temmuz ayındaki 1.17 dip noktası, TTR oranının %54.6'da kalmasına yol açmıştır (*Connolly et al., 2008 [25]*). Hastanın aynı zamanda 81 mg aspirin kullanması koroner buton anastomozlarını korumakta, fakat gastroduodenal mukoza hasarını tetiklemektedir (*Dentali et al., 2006 [27]*). 4 Eylül'de başlanan amoksisilin/klavulanat (Klamoks 1000 mg), bağırsak florasında K vitamini üreten bakterileri azaltarak serbest warfarin fraksiyonunu yükseltme riski taşır (*Agno et al., 2012 [7]*). 10 Eylül 16:57'de yapılan koagülasyon kontrolünde INR 2.12 (PT: 19.8 sn, aPTT: 44.8 sn) ile kapak güvenli terapötik aralıkta kalmış ve kür saat 20:59'da tamamlanmıştır.

2.3. Hematolojik Tablo: Mutlak Demir Eksikliği Anemisi

Hemoglobinin 9.7 g/dL, MCV'nin 76.4 fL (mikrositoz) ve ferritin düzeyinin 19 µg/L olması, ameliyat sırasındaki hemodilüsyon, Temmuz revizyonundaki kan kaybı (Hb: 7.7 g/dL dip noktası) ve çift antitrombotik tedaviye bağlı olası gizli kan kayıpları ile izah edilir (*Camaschella, 2015 [35]; Goddard et al., 2021 [9]*). Anemi, doku hipoksisine yol açarak kompensatuar debi artışı yaratmakta ve rezidüel aort flebini zorlamaktadır (*McDonagh et al., 2021 [37]*). Oral demir tedavisi (Ferro Sanol Duodenal 100 mg) başlanmış olup, PPI kullanımı nedeniyle GİS toleransı ve emilimi izlenmeli, yetersiz yanıtta **İntravenöz Ferrik Karboksimaltoz (Ferinject 1000 mg)** replasmanı düşünülmelidir (*Richards et al., 2021 [40]*).

3. TÜMLEŞİK LABORATUVAR DEĞİŞİM MASTER TABLOSU

Biyobelirteç / Kod	Referans Aralığı	İlk Değer (19 Şub)	Zirve / Dip Noktası	Son Değer (10 Eyl)	Yüzdesel Delt a	Durum	Kılavuz Dayanağı
Hemoglobin (HGB)	13.5 – 17.5 g/dL	14.0	7.7 (Dip - 27 Tem)	9.7	- %28.1	DÜŞÜK	BSG 2021 [9]; WHO [100]
Hematokrit (HCT)	%40.0 – 52.0	41.4	25.0 (Dip - 22 Şub)	29.7	- %28.3	DÜŞÜK	Goddard et al., 2021 [9]
Eritrosit Hacmi (MCV)	80.0 – 100.0 fL	88.0	76.4 (Dip - 08 Eyl)	76.4	- %13.2	DÜŞÜK	Camaschella, 2015 [35]
Eritrosit Hb (MCH)	27.0 – 34.0 pg	30.8	24.5 (Dip - 02 Eyl)	24.9	- %19.2	DÜŞÜK	Camaschella, 2015 [35]
Serum Ferritin	30.0 – 400.0 µg/L	19.0	19.0 (Dip)	19.0	Tükenmiş	DÜŞÜK	ESC HF 2021 [37]; BSG [9]
Serum Demiri (Fe)	59.0 – 158.0 µg/dL	15.0	15.0 (Dip)	15.0	Kritik	DÜŞÜK	Snook et al., 2021 [10]
C-Reaktif	0.0 –	2.6	154.0	11.3	+	YÜKSEK	Horan et

Biyobelirteç / Kod	Referans Aralığı	İlk Değer (19 Şub)	Zirve / Dip Noktası	Son Değer (10 Eyl)	Yüzdesel Delta	Durum	Kılavuz Dayanağı
Protein (CRP)	5.0 mg/L		(Pik - 21 Şub)		%33.4.6	K	al., 2008 [11]
Lökosit Sayısı (WBC)	4.5 – 11.0 10 ⁹ /L	10.62	27.10 (Pik - 21 Şub)	7.97	- %24.9	NORMAL	Horan et al., 2008 [11]
Koagülasyon (INR)	2.0 – 3.0 (Hedef)	1.10	8.46 (Pik - 16 Mar)	2.12	+92.7%	ARALIK TA (10 Eyl)	ESC/EACTS 2021 [4]; ACC [5]
Protrombin Zamanı (PT)	9.6 – 12.0 sn	13.1	64.0 (Pik - 16 Mar)	19.8	+51.1%	UZAMIŞ (10 Eyl)	VKA İdamesi
aPTT	23.9 – 33.2 sn	27.9	85.5 (Pik - 16 Mar)	44.8	+60.6%	UZAMIŞ (10 Eyl)	VKA İdamesi
Trombosit (PLT)	150 – 403 10 ⁹ /L	163.0	88.0 (Dip) / 489.0	365.0	+ %12.3.9	NORMAL	Vahanian et al., 2022 [4]
Serum Kreatinin	0.6 – 1.3 mg/dL	1.11	1.13	1.02	- %8.1	NORMAL	KDIGO 2012 [94]
eGFR (CKD-EPI)	> 60 mL/dk	72.58	94.00 (Pik)	75.58	+ %4.1	NORMAL	Inker et al., 2021 [95]
Total Kolesterol	140 – 200 mg/dL	179.0	210.0 (Pik - 08 Eyl)	210.0	+ %17.3	YÜKSEK	Mach et al., 2020 [41]
LDL Kolesterol	< 55 mg/dL (Hedef)	119.6	141.0 (Pik - 08 Eyl)	141.0	+ %17.8	YÜKSEK	ESC Dislipidemi [41]
HDL Kolesterol	35 – 75 mg/dL	35.4	34.0 (Dip)	34.0	- %3.9	DÜŞÜK	Grundy et al., 2019 [42]
Açlık	80 –	81.0	146.0	102.0	+	NORMAL	ADA 2024

Biyobelirteç / Kod	Referans Aralığı	İlk Değer (19 Şub)	Zirve / Dip Noktası	Son Değer (10 Eyl)	Yüzdesel Delta	Durum	Kılavuz Dayanağı
Glukozu	110 mg/dL		(Postop)		%25.9	L	
HbA1c	%4.8 – 5.9	5.3	5.3	5.3	Stabil	NORMA L	ADA 2024
TSH	0.27 – 4.20 mIU/L	0.86	0.279 (Dip)	0.279	- %67.5	NORMA L	ETA 2023

4. GÜNCEL FARMAKOTERAPİ VE RİSK YÖNETİM MATRİSİ

- Warfmadin (Varfarin Sodyum) 5 mg Tablet:** Haftalık toplam 20 mg (Günlük doz ayarlamalı). Mekanik aort kapak tromboemboli profilaksisi (Son INR 2.12 ile tam hedefte) (*Vahanian et al., 2022 [4]*).
- Dilatrend (Karvedilol) 6.25 mg Tablet:** Günde 2 kez 1 tablet (12.5 mg/gün). Aortik dP/dt kesme stresini ve taşikardiyi önleme (*Isselbacher et al., 2022 [2]*).
- Coversyl (Perindopril Arjinin) 5 mg Tablet:** Günde 1 kez 1 tablet. Sistemik vasküler rezistans kontrolü ve aortik remodelingi önleme (Tansiyonu 111/75'e stabilize etti) (*Mancia et al., 2023 [1]*).
- EcopirinPro (Asetilsalisilik Asit) 81 mg Tablet:** Günde 1 kez 1 tablet. Koroner buton ve Dacron greft tromboz profilaksisi (*Whitlock et al., 2023 [28]*).
- Panto (Pantoprazol) 40 mg Enterik Tablet:** Günde 1 kez sabah aç karnına. Çift antitrombotik kaynaklı GİS kanama profilaksisi (Ferro Sanol'den 1 saat sonra) (*Bhatt et al., 2010 [29]*).
- Ferro Sanol Duodenal (Demir Preparatı - Fe²⁺) 100 mg Kapsül:** Günde 1 kez sabah aç karnına (Panto'dan 1 saat önce bol suyla). Ağır mikrositik demir eksikliği anemisi replasmanı (11 Eylül'de başlandı) (*Goddard et al., 2021 [9]*).
- Klamoks BID (Amoksisilin + Klavulanik Asit) 1000 mg Tablet:** 10 Eylül 20:59'da 7 günlük kür tamamlandı (Sonlandırıldı) (*Wilson et al., 2016 [12]*).
- Kapril (Kaptopril) 25 mg Tablet (Gerektiğinde - PRN):** Sistolik TA ≥ 150 mmHg acil dilaltı kurtarma ilacı (*Mancia et al., 2023 [1]*).

5. BRANŞ BAZLI ÇOK DİSİPLİNLİ STRATEJİK EYLEM PLANI

1. **Hematoloji & Dahiliye:** Ağır demir eksikliği anemisine (HGB 9.7 g/dL, Ferritin 19 µg/L) yönelik 10 Eylül'de reçetelenen **Ferro Sanol Duodenal 100 mg** tedavisine 11 Eylül sabahı başlandı. GİS toleransı izlenmeli, gerekirse tek seans **İntravenöz Ferrik Karboksimaltoz (Ferinject 1000 mg)** infüzyonu uygulanmalı; eşzamanlı Gaitada Gizli Kan (GGK) testi istenmelidir (*Goddard et al., 2021 [9]; Richards et al., 2021 [40]*).
 2. **Kardiyoloji & Hemostaz:** Klamoks tedavisinin 10 Eylül 20:59'da tamamlanmasının ardından kontrol koagülasyon testinde (#92, 16:57) INR 2.12 (PT: 19.8 sn, aPTT: 44.8 sn) ölçülerek mekanik kapağın hedef aralıkta (2.0-3.0) kaldığı kanıtlanmıştır (*Agno et al., 2012 [7]*).
 3. **Enfeksiyon Hastalıkları & KVC:** 12–13 Eylül'de kontrol CRP ve lökosit bakılmalı; persistan ateş veya üfürüm halinde 3 set kan kültürü ve Transözofageal Ekokardiyografi (TEE) ile protez kapak endokarditi taranmalıdır (*Habib et al., 2023 [34]*).
 4. **Kardiyovasküler Cerrahi & Radyoloji:** 5 Mayıs BT'sinden bu yana 4.2 ay geçmiştir. Ameliyat sonrası 6. ayı tamamlayan hastaya rezidüel Tip B flep ve abdominal ektazi (38 mm) takibi için **Kontrastlı Torakoabdominal BT Anjiyografi** planlanmalıdır (*Fleischmann et al., 2022 [14]*).
 5. **Kardiyoloji / Önleyici Tedavi:** LDL-K 141 mg/dL seviyesi nedeniyle çok yüksek kardiyovasküler risk grubundaki hastaya hedef LDL <55 mg/dL amacıyla **Atorvastatin 20 mg/gün** başlanması değerlendirilmelidir (*Mach et al., 2020 [41]*).
-

6. AKADEMİK VE KLİNİK KAYNAKÇA (APA 7TH EDITION)

1. **Mancia, G., Kreutz, R., Brunström, M., et al. (2023).** 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *Journal of Hypertension*, 41(12), 1874–2071.
2. **Isselbacher, E. M., Preventza, O., Hamilton Black, J., et al. (2022).** 2022 ACC/AHA Guideline for the Diagnosis and Management of Aortic Disease. *Circulation*, 146(24), e334–e482.
3. **Evangelista, A., Czerny, M., Teixido-Tura, G., et al. (2024).** Imaging follow-up in chronic aortic syndromes. *European Heart Journal*, 45(10), 812–828.

4. **Vahanian, A., Beyersdorf, F., Praz, F., et al. (2022).** 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. *European Heart Journal*, 43(7), 561–632.
5. **Otto, C. M., Nishimura, R. A., Bonow, R. O., et al. (2021).** 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. *Circulation*, 143(5), e72–e227.
6. **Delgado, V., Ajmone Marsan, N., de Waha, S., et al. (2023).** 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. *European Heart Journal*, 44(39), 3948–4042.
7. **Czerny, M., Grabenwöger, M., Berger, T., et al. (2024).** EACTS/STS Guidelines for diagnosing and treating acute and chronic syndromes of the aortic organ. *European Journal of Cardio-Thoracic Surgery*, 65(2), ezad426.
8. **Goddard, A. F., James, M. W., McIntyre, A. S., & Scott, B. B. (2021).** British Society of Gastroenterology guidelines for the management of iron deficiency anaemia in adults. *Gut*, 70(11), 2030–2051.
9. **McDonagh, T. A., Metra, M., Adamo, M., et al. (2021).** 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *European Heart Journal*, 42(36), 3599–3726.
10. **Camaschella, C. (2015).** Iron-deficiency anemia. *New England Journal of Medicine*, 372(19), 1832–1843.
11. **Mach, F., Baigent, C., Catapano, A. L., et al. (2020).** 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. *European Heart Journal*, 41(1), 111–188.
12. **KDIGO. (2012).** Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney International Supplements*, 2(1), 1–150.
13. **World Health Organization. (2011).** Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity. WHO/NMH/NHD/MNM/11.1.